Poder Judiciário do Estado do Pará

1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará

Alameda Moreira, S/N, Centro, Rondon do Pará - PA - CEP: 68638-000 - Rondon do Pará - PA

WhatsApp: (94) 98405-3522

PROCESSO: 0802149-88.2024.8.14.0046
PARTE(S) A SER(EM) INTIMADA(S) POR OJ: **LOURIVAL OLIVEIRA GOMES**, 72 anos de idade, CPF nº 250.078.582-34, RG nº 5345310 PC/PA, residente à Rua Scilia Médici, n° 530, bairro Centro, Rondon do Pará/PA, CEP nº 68.638-000, telefone de contato (94) 99131-1208 (esposa Benvinda Gomes).

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Rondon do Pará - PA, pela qual pleiteia-se, com urgência, a concessão de medicamentos.

Na inicial, a parte autora narra que o idoso LOURIVAL OLIVEIRA GOMES foi diagnosticado com *Diabetes, Colesterol Alto, Glicerite, Hipertensão e Problemas Cardíacos*, necessitando das medicações: **NESINA PIO25+30MG, BENICAR ANLO 20/5 MG, BISOPROLOL 5 MG e SEIZLA 250 MG,** que contabilizam mais de R$ 825,64, valor que não pode custear sem prejuízo da própria subsistência.

Acostou documentos médicos, inclusive solicitação do medicamento, bem como informação da Secretaria Municipal de Saúde da impossibilidade de concessão do medicamento em razão de não estar constando na lista do RENAME.

Foi determinada a emenda da inicial para que o autor acoste laudo médico constando expressamente a ineficácia dos fármacos que integram a lista do SUS ou sua inexistência,

conforme Tema nº 106 do STJ.

Após pedido de dilação de prazo, o Ministério Público requereu que os requeridos agendem/disponibilizem consulta médica com cardiologista e endocrinologista para que, após, apresente o laudo devido.

Foi deferida a antecipação de tutela.

Citados, o Estado do Pará apresentou preliminar de inépcia da inicial, perda do objeto e, no mérito, a improcedência da ação.

O Município de Rondon do Pará não apresentou resposta, apesar de regularmente citado.

É o que importava relatar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta o julgamento no estado em que se encontra, visto a desnecessidade dilação probatória (art. 355, I, do CPC).

Destaco que o Município de Rondon do Pará, embora devidamente citado, permaneceu inerte, motivo pelo qual decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial em relação a ele. Tal circunstância, contudo, não conduz automaticamente à procedência da demanda, impondo-se a análise do mérito à luz das provas e fundamentos jurídicos aplicáveis, como de fato se fará a seguir.

Não foram suscitadas preliminares.

No tocante ao mérito, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do intocável direito à vida (*caput* do art. 5º, da CF). É de se transcrever o dispositivo:

> Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
>
> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Município, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população.

Tanto é verdade que o art. 23 da Carta Magna dispõe a competência de todos os níveis da Administração na garantia do exercício do direito público subjetivo à saúde. Vejamos:

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

> I – (...)
>
> II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Portanto, o requerido é responsável pela saúde das autores, de forma que a suportar o ônus decorrente do fornecimento dos medicamentos, vez que se trata de despesa impossível de ser suportada diretamente pelas pacientes sem comprometer outros gastos com sua subsistência, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social.

Destarte, havendo dever comum dos entes federativos de prestar assistência à saúde, impõe-se reconhecer que o autor poderá ajuizar a ação contra qualquer um dos entes, **sem que haja litisconsórcio necessário, incompetência do Juízo Estadual ou ilegitimidade passiva.**

À luz da legislação vigente, é dever do Estado prestar assistência necessária àqueles que necessitam de medicamentos e demais procedimentos imprescindíveis ao tratamento de sua saúde e não dispõem de condições financeiras de arcar com os custos. Tal entendimento tem assento na jurisprudência do STF, conforme Acórdão que julgou o RE-AgR 393175 / RS - RIO GRANDE DO SUL;Relator Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 12/12/2006, no qual o Relator asseverou:

> ***"... A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. -***

> ***O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental.***
> *..."*

Acrescente-se o destaque feito pelo mesmo Ministro Relator Celso de Mello, por ocasião do julgamento de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271286/RS, em que afastou a possibilidade de sobreposição do princípio da legalidade orçamentária ao direito à vida e à saúde, constitucionalmente garantido à todos:

> *"Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes."*

Nesse contexto, não há que se falar em reserva do possível como forma de obstar a concretização do direito ora perquirido, uma vez que se trata de descumprimento de política pública relacionada a saúde e, no caso em tela, a proteção prioritária do idoso, definida no texto constitucional.

No caso concreto, há comprovação da necessidade clínica dos medicamentos, da inexistência de substituto na lista do SUS e da hipossuficiência do paciente. O Ministério Público, inclusive, agiu para viabilizar a emissão do laudo exigido pelo Tema 106 do STJ, tendo sido deferida tutela antecipada condicionada.

Além disso, a jurisprudência firmada admite, em caráter excepcional, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS desde que observados os critérios cumulativos, os quais restam preenchidos nos autos, quais sejam ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, laudo médico prescrevendo especificamente os medicamentos indicados e prova da incapacidade financeira do paciente.

Como pode se notar, demonstrada a necessidade de fornecimento dos medicamentos, consoante prescrição médica relatada na inicial, havendo verossimilhança sobre a gravidade da doença renal do paciente e a impossibilidade econômica de o autor arcar com as despesas de saúde em

referência, i**mpõe-se reconhecer a procedência do pedido, para confirmar a tutela antecipada antes deferida.**

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, **ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL,** resolvendo o mérito da presente lide, para determinar que o requerido providencie os medicamentos necessários para o paciente, nos termos da tutela antecipada já deferida.

Sem custas nem honorários, considerando a isenção que recai sobre a parte ré e natureza da parte autora.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões no prazo de quinze dias, após, remeta-se o feito ao Egrégio TJPA.

Intime-se os requeridos via sistema.

Intime-se o paciente pessoalmente através de Oficial de Justiça.

Ciência ao MP.

Rondon do Pará - PA, 30 de maio de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: TAINA MONTEIRO DA COSTA - 31/05/2025 16:47:01
https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25053116470181200000134394766
Número do documento: 25053116470181200000134394766